

Hasta Durumu ve Gidişat Raporu

19 Şubat 2026 – 10 Eylül 2026 Klinik Seyir Analizi: Ham Veri İncelemesi, Boylamsal Trendler ve Güncel Bilimsel Kılavuz Karşılaştırması

Kapsam ve güvenlik notu | | Bu rapor, yüklenen klinik veri dökümündeki ölçüm, laboratuvar, | görüntüleme, epikriz ve ilaç kayıtlarını; 2022 ACC/AHA Aort | Hastalığı, 2025 ESC/EACTS Kapak Hastalıkları ve 2023 ESC Enfektif | Endokardit kılavuzları ile karşılaştırmalı olarak yorumlar. Bu belge | tanı koymaz ve ilaç dozu değiştirme talimatı değildir. Özellikle | mekanik kapak, warfarin ve aktif/en yakın dönem sternal yara | enfeksiyonu nedeniyle değişiklikler ilgili branş hekimlerince | yapılmalıdır. |

Raporun veri kesim tarihi: 10 Eylül 2026. Dosya “All Historical Data” dışı aktarımıdır. Kişisel iletişim/kimlik bilgileri bu raporda bilerek tekrar edilmemiştir.

1. Yönetici özeti

Klinik seyir, Şubat 2026’da hayatı tehdit eden akut Tip A aort diseksiyonu ve ciddi aort kapak yetmezliği nedeniyle yapılan acil Bentall operasyonundan sonra belirgin hemodinamik stabilizasyon dönemine girildiğini; ancak iki önemli kronik/aktif sorunun devam ettiğini gösteriyor: (1) cerrahi sonrası rezidüel diseksiyonun uzun dönem görüntüleme takibi ve (2) sternal yara komplikasyonlarıyla birlikte seyreden inflamasyon + belirgin demir eksikliği anemisi. Mekanik aort kapağı açısından son INR 2,12 olup (10 Eylül 2026 Test #92), ek tromboembolik risk faktörü yoksa güncel ESC/EACTS hedef aralığı olan 2,0-3,0 içindedir [2].

En olumlu gelişme | | Son 7 gündeki 15 ev ölçümünün ortalaması yaklaşık 111/75 mmHg; | dönemin 23 Temmuz-10 Eylül ham ortalaması 118,6/79,5 mmHg. Bu değerler aort duvar stresinin azaltılması açısından uygun bir kontrol düzeyine | işaret ediyor. 2024 ESC hipertansiyon kılavuzunun tedavi alan | yetişkinler için 120-129 mmHg sistolik hedefini de genel olarak | karşılıyor; tolerans ve semptomlar bireyselleştirilmelidir [5]. |

+—————+ | **En önemli çözülmemiş konu** | | | 8 Eylül’de HGB 9,7 g/dL, MCV 76,4 fL, ferritin 19 µg/L ve demir 15 | µg/dL. UIBC 326,8 µg/dL ile hesaplanan transferrin satürasyonu | yaklaşık %4,4’tür. Bu tablo doğrultusunda 10 Eylül’de Ferro Sanol | Duodenal 100 mg

reçete edilmiş ve 11 Eylül'de başlanmıştır. Ancak erkek | | hastada etiyolojik kaynak araştırması sürdürülmelidir [4]. |

+=====

+-----+ | **En önemli güvenlik konusu** | | | Warfarin kontrolü geçmişte belirgin dalgalı: INR 16 Mart'ta 8,46'ya | | kadar çıkmış, Temmuz sonunda 1,17'ye kadar düşmüş; son değer 2,12 (10 Eylül). | | 4 Eylül'de başlanan 7 günlük ampirik Klamoks kürü 10 Eylül 20:59'da | | başarıyla tamamlanıp kesilmiştir; kür sonu yapılan 10 Eylül kontrolünde | | korkulan supratherapötik INR sıçraması görülmemiş, INR 2,12 ile hedefte | | kalmıştır [2,8]. |

+=====

Aort için temel takip sorusu | | 5 Mayıs CTA'sında cerrahi operasyon yatağı stabil olmakla birlikte | diseksiyon flebinin arkus dallarından başlayıp inen aorta ve iliak | bifurkasyona kadar devam ettiği, abdominal aortanın 38 mm olduğu | kayıtlıdır. 2022 ACC/AHA kılavuzu rezidüel aort hastalığında 1, 6 ve | 12 ayda, ardından stabilite varsa yıllık CT/MR görüntüleme önerir | [1]. Dosyada 5 Mayıs'tan sonra tekrar kontrastlı torakoabdominal | aort görüntülemesi görünmemektedir; bu, planlanması gereken | başlıklardan biridir. |

2. Klinik zaman çizelgesi ve kritik dönemeçler

Tarih Dönüm noktası Klinik anlam

19.02.2026 Akut başvuru Ani yırtıcı göğüs-sırt ağrısı; Tip A diseksiyon şüphesi, ileri merkeze sevk.

19.02.2026 Tanı Torakoabdominal CTA: 5,3 cm asendan aort anevrizması + aort kökünden iliak bifurkasyona uzanan Tip A diseksiyon.

20.02.2026 Acil cerrahi Bentall: 32 mm Dacron asendan aort/hemiark grefti + 25 mm Carbomedics bileaflet mekanik aort kapağı + koroner buton reimplantasyonu.

02.03.2026 Taburculuk Postoperatif dönem sonrası; ömür boyu warfarin gereksinimi kaydedildi.

12-30.03.2026 Antikoagülasyon sorunu INR 5,74 → 8,46 → 6,04 → 5,87 → 4,52 → 4,64; belirgin supratherapötik dönem.

30-31.03.2026 Yatış 5 gün dışkılayamama, bulantı-kusma; CRP 101,4 mg/L, inflamasyon yüksek; lavman ile rahatlama.

16-18.04.2026 Hipertansif ataklar Ev ölçümleri 156/97, 152/102 ve 168/103 mmHg'ye kadar yükseldi; kriz müdahaleleri kaydedildi.

05.05.2026 Aort kontrol CTA Operasyon yatağı stabil; rezidüel kronik diseksiyon inen aorta ve iliaklara devam ediyor; abdominal aorta 38 mm.

17.07.2026 Toraks BT Minimal perikardiyal efüzyon, artmış kardiyotorasik oran, sternal defekt; pnömotoraks/hemotoraks/plevral efüzyon yok.

23-28.07.2026 Sternal yara İnsizyon dehiscensi, ağır komplikasyonu enfeksiyon/doku defekti; sütürler ve yoğun yara bakımı; aynı dönemde INR 1,79 → 1,17, HGB 11,3 → 7,7 g/dL.

01-25.08.2026 Antikoagülasyon INR 1,21 → 1,55 → 1,70 → 2,59 → toparlanması 2,76.

04-10.09.2026 Antibiyoterapi kürü Klamoks 1000 mg günde 2 kez; 10 Eylül 20:59'da tamamlandı.

08-10.09.2026 Mevcut durum HGB 9,7; CRP 11,3; WBC 7,97; kreatinin 1,02; INR 2,12 (PT 19,8 s, aPTT 44,8 s); tansiyon son 7 gün 111/75 ortalama; son tartım 78,4 kg. Ferro Sanol Duodenal başlandı.

Veri kalitesi notu: Dışa aktarım içindeki otomatik “klinik değerlendirme” metni bazı toplamları/ortalamaları ham satırlarla tam eşleştirmiyor ve 4 Eylül'de başlayan Klamoks kaydıyla “ilaç değişikliği yok” ifadesi arasında çelişki bulunuyor. Bu nedenle aşağıdaki analizlerde timestamp'li ham kayıtlar önceliklidir. Kaynak dosyanın otomatik rapor metninde ilaç ve sayı düzeyinde iç tutarsızlıklar olduğu görülmektedir. filecite turn2file0 L5-L10

3. Aort diseksiyonu ve Bentall sonrası anatomik durum

19 Şubat 2026'da saptanan hastalık, asendan aortu ve aort kökünü tutan Tip A diseksiyon ile 5,3 cm anevrizmatik genişleme ve ciddi aort kapak yetmezliği kombinasyonudur. 20 Şubat'ta yapılan Bentall operasyonunda 32 mm Dacron

greft, mekanik aort kapağı ve koroner buton reimplantasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu cerrahi, akut Tip A diseksiyon için standart ve hayat kurtarıcı onarım çerçevesindedir; ancak ameliyat edilen asendan segmentin düzelmiş olması, distal aortun riskinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez [1].

5 Mayıs 2026 kontrol CTA'sı, operasyon yatağını stabil göstermesi açısından olumlu bir bulgudur. Buna karşılık diseksiyon flebinin arkus dalları ile inen aorta ve iliak bifurkasyona kadar sürmesi rezidüel distal diseksiyonun devam ettiğini gösterir. Abdominal aorta suprarenal düzeyde 38 mm ölçülmüş ve "stabil ektazi" olarak raporlanmıştır. Dosyada bu tarihten sonra kontrastlı torakoabdominal CTA/MR bulunmamaktadır.

Aort segmenti / 05.05.2026 Yorum bulgu****

Operasyon bölgesi Stabil Greft yatağı açısından olumlu.

Aort kökü 46 mm Ölçüm mevcut; post-Bentall anatomiye göre kardiyovasküler cerrah/radyoloji karşılaştırması önemli.

Arkus 46 mm Rezidüel diseksiyon dallarla ilişkili; seri ölçüm önemli.

İnen aorta 39 mm Rezidüel diseksiyon devam ediyor.

Abdominal aorta 38 mm Stabil ektazi; seri görüntüleme gerekir.

İliaklar Sol ana ve eksternal Distal rezidüel iliak diseke segment hastalık sürüyor. devamı _____

Kılavuz karşılaştırması | | 2022 ACC/AHA Aort Hastalığı kılavuzu, akut aort sendromu sonrası | rezidüel aort hastalığında CT veya MR ile 1., 6. ve 12. aylarda, daha sonra stabilse yıllık gözetim önerir. Bu nedenle 20 Şubat | cerrahisinden yaklaşık 6-7 ay sonra, 2026 yaz sonu/sonbahar döneminde toraks-abdomen-pelvis düzeyini kapsayan planlı aort görüntülemesinin | dosyada bulunup bulunmadığı özellikle teyit edilmelidir [1]. |

17 Temmuz nonkontrast toraks BT'si sternal defekt ve minimal perikardiyal efüzyon gibi bulguları gösteriyor; ancak kontrastsız olduğundan diseksiyon flebinin lümen içi seyri ve aort çaplarının seri karşılaştırması için 5 Mayıs CTA'nın yerini tutmaz. Bu, görüntüleme modalitesi farkı nedeniyle önemlidir [1].

4. Mekanik aort kapağı ve warfarin yönetimi

Dosyada 25 mm Carbomedics çift yapraklı mekanik aort kapağı bulunmaktadır. 2025 ESC/EACTS kılavuzunda güncel nesil bileaflet mekanik aort kapağı ve ek tromboembolik risk faktörü olmayan hasta için VKA hedef INR 2,5 (terapötik aralık 2,0-3,0) olarak verilir; ek risk faktörleri varsa hedef 3,0 (2,5-3,5) olur. Mekanik kapaklarda ömür boyu VKA tedavisi gerekir ve DOAC'lar uygun değildir [2].

Dönem INR örnekleri Klinik anlam

Ameliyat sonrası 1,10-3,36 Antikoagülasyonun başlangıç kurulma dönemi.

12-30 Mart 5,74; 8,46; 6,04; 5,87; Belirgin supratherapötik 4,52; 4,64 dönem; kanama açısından yüksek risk.

Nisan-Haziran 2,92 → 2,03 → 1,77 → Dönem içinde sık 1,65 → 1,94 → 2,05 → subterapötik değerler. 2,18

15.07.2026 2,46 Hedef aralık içinde.

23-31.07.2026 1,79 → 1,18 Belirgin subterapötik dönem; bridging kaydı mevcut.

03-11.08.2026 1,21 → 1,55 → 1,70 Hâlâ düşük; toparlanma.

18.08-10.09.2026 2,59 → 2,76 → 2,72 → 2,12 Güncel hedef aralıkta ve stabil.

Ham dosyada 39 INR sonucu bulunmaktadır. Basit “ölçüm sayısı içinde 2,0-3,0 arası” hesabında 11/39 (%28,2) sonuç bu aralıktadır; 21/39 ölçüm 2’nin altında, 7/39 ise 3’ün üzerindedir. Bu oran perioperatif dönemi de içerdiği için gerçek TTR (time in therapeutic range) değildir. Zaman eksenini üzerinde doğrusal interpolasyonla yapılan kaba hesap, 2 Mart-10 Eylül döneminde terapötik aralıkta yaklaşık %55,4 zaman göstermektedir; 1 Ağustos-10 Eylül alt döneminde bu yaklaşık %62,8’dir. Bunlar dosyadaki seyrek INR ölçümleri nedeniyle yaklaşık tahminlerdir ve antikoagülasyon kliniğinin kullandığı resmi TTR ölçümünün yerine geçmez [2].

Aspirin konusu ayrıca gözden geçirilmeli | | Dosyada EcopirinPro 81 mg/gün ile warfarin birlikte görülmektedir. | 2025 ESC/EACTS kılavuzu mekanik kapakta ilk seçenek olarak VKA tek | başına tedaviyi vurgular; düşük doz aspirin eklenmesi özellikle | yeterli INR/TTR'ye rağmen büyük tromboemboli gelişmesi gibi seçilmiş | durumlarda düşünülür [2]. Bu hastada geçmişte belirgin anemi ve | sternal yara komplikasyonu da olduğundan, aspirin için klinik | endikasyonun dosyada açık biçimde bulunması ve kanama riskinin | dengelenmesi önemlidir. Bu, ilacı kendiliğinden kesme önerisi | değildir. |

5. Kan basıncı, hemodinami ve dolaşım güvenliği

İlk akut/postoperatif dönem (19 Şubat-31 Mart): 69 ölçüm; ortalama 109.2/76.8 mmHg; en yüksek 154/98; en düşük 83/60 mmHg.

Nisan-Temmuz (22 Temmuz'a kadar): 283 ölçüm; ortalama 118.9/81.2 mmHg; en yüksek 168/103; en düşük 85/60 mmHg.

Yara komplikasyonu sonrası (23 Temmuz-10 Eylül): 137 ölçüm; ortalama 118.6/79.5 mmHg; en yüksek 149/101; en düşük 99/60 mmHg.

Son 7 gün (4-10 Eylül): 15 ölçüm; ortalama 111/75 mmHg; en yüksek 120/80; en düşük 101/68 mmHg.

Dönem	Ölçüm	Ort.	Ort. Maksimum	sistolik**	diyastolik**
-------	-------	------	---------------	------------	--------------

19.02-31.03	69	109.2	76.8	154/98
-------------	----	-------	------	--------

01.04-22.07	283	118.9	81.2	168/103
-------------	-----	-------	------	---------

23.07-10.09	137	118.6	79.5	149/101
-------------	-----	-------	------	---------

04.09-10.09	15	111.0	75.0	120/80
-------------	----	-------	------	--------

16-18 Nisan'daki 146/93, 156/97, 152/102 ve 168/103 mmHg ölçümleri tarihsel olarak dikkat çekicidir; ancak 23 Temmuz sonrası 137 ölçümde ortalama 118,6/79,5 mmHg'ye inmiş olması belirgin bir iyileşmedir. 2022 ACC/AHA aort hastalığı kılavuzu torasik aort hastalığında kan basıncının kontrolünü vurgular; akut aort sendromunda başlangıçta daha sıkı SBP/HR hedefleri kullanılır, kronik dönemde ise uzun süreli beta-blokaj ve uygun antihipertansif tedavi önerilir [1].

Mevcut hemodinamik tablo | | Son hafta 101/68 ile 120/80 arasında seyreden ölçümler, yüksek basınç dalgalanmalarının azaldığını gösteriyor. 2024 ESC hipertansiyon | kılavuzu tedavi alan çoğu yetişkinde 120-129 mmHg sistolik hedefi | önerir; semptomatik ortostaz veya tolerans sorunu varsa daha gevşek | hedefler düşünülebilir [5]. Dolayısıyla 111/75 tek başına “fazla | düşük” kabul edilmemeli; baş dönmesi, senkop, soğukluk/hipoperfüzyon | gibi semptomlar varsa hekimle yeniden değerlendirilmelidir. |

6. Sternal yara, enfeksiyon ve protez kapak endokarditi açısından değerlendirme

Seyir, Mart ayından itibaren tekrarlayan inflamasyon göstergeleri ve Temmuz sonunda sternal insizyon dehisensi/ağır enfeksiyon ile komplike olmuştur. 30 Mart CRP 101,4 mg/L ve WBC 12,05 $\times 10^9/L$ ile yüksek inflamasyon; 31 Mart CRP 84,7 mg/L; 15 Haziran 22,7 mg/L; 15 Temmuz 15,6 mg/L; 23 Temmuz 9,9 mg/L; 7 Ağustos 34,3 mg/L; 25 Ağustos 5,6 mg/L; 2 Eylül 23,8 mg/L; 8 Eylül 11,3 mg/L olarak kaydedilmiştir.

Tarih CRP (mg/L) WBC Yorum ($\times 10^9/L$)

30.03 101.4 12.05 Yüksek inflamasyon; aynı dönemde yatış ve sternal yara takibi.

15.06 22.7 - Persistan fakat azalmış inflamasyon.

15.07 15.6 - Devam eden inflamasyon.

23.07 9.9 - Sternal yara komplikasyonu sırasında hâlâ yüksek.

07.08 34.3 9.96 Tedavi/komplikasyon sürecinde yeniden yükselme.

25.08 5.6 9.33 Normal sınıra çok yakın CRP.

02.09 23.8 9.96 Yeniden belirgin yükseliş.

08.09 11.3 7.97 Düşüş var, ancak hâlâ referans üstü.

8 Eylül’de WBC’nin 7,97’ye, CRP’nin 23,8’den 11,3 mg/L’ye düşmesi enfeksiyon/inflamasyon yükünde son günlerde iyileşme olduğunu düşündürüyor. Buna rağmen mekanik/protez kapak ve yakın dönem sternal enfeksiyon öyküsü

nedeniyle “endokardit yok” sonucuna yalnızca bu kan değerleriyle varılamaz. 2023 ESC endokardit kılavuzu tanıyı klinik, mikrobiyolojik ve görüntüleme kanıtlarının birleşimiyle ele alır; prostetik kapaklı hastada şüphe varsa TTE’ye ek olarak TEE önemli bir tanısal araçtır [3].

Dosyada eksik görünen endokardit değerlendirmeleri | | Mevcut dışa aktarımda 2026 yaz sonu için pozitif kan kültürü, TTE/TEE bulguları, protez kapak vegetasyonu, paravalvüler apse/dehisens veya | FDG-PET/CT gibi prostetik materyal enfeksiyonu değerlendirmesini | doğrulayan bir sonuç görünmüyor. Bu nedenle endokardit tanısı | konulamaz; ancak açıklanamayan ateş, titreme, yeni üfürüm/kapak sesi | değişikliği, embolik nörolojik bulgu, gecikmiş iyileşen sternal | enfeksiyon veya persistans gösteren CRP gibi bulgular varsa düşük | eşikle enfeksiyon-kardiyoloji değerlendirmesi gerekir [3]. |

26 Mart tarihli yara kültürü kaydında “üreme olmadı” bilgisi bulunması, daha sonra ortaya çıkan derin/tekrarlayan enfeksiyonu tek başına dışlamaz. Özellikle antibiyotik kullanımı kültür verimini etkileyebilir; klinik şüphede uygun kan kültürleri ve hedefli görüntüleme önemlidir [3].

7. Anemi ve demir eksikliği: şu anki en belirgin laboratuvar sorunu

8 Eylül 2026 sonuçları belirgin mikrositik-hipokromik anemi ile birlikte demir depolarında azalma gösteriyor: HGB 9,7 g/dL, HCT 29,7%, RBC 3,89 x10¹²/L, MCV 76,4 fL, MCH 24,9 pg, RDW-CV 17,8%, ferritin 19 µg/L, demir 15 µg/dL. B12 638 pg/mL ve tiroid serbest hormonları normal aralıkta. UIBC 326,8 µg/dL ile hesaplanan transferrin saturasyonu yaklaşık %4,4’tür.

Parametre 08.09.2026 Laboratuvar Yorum sınırı

HGB 9,7 g/dL 13,5-17,5 Belirgin anemi

HCT 29,7 % 40-52 Düşük

RBC 3,89 4,2-6,2 Düşük

MCV 76,4 fL 80-100 Mikrositoz

MCH 24,9 pg 27-34 Hipokromi

RDW-CV 17,8 % 10-16,5 Hücre boyutu heterojenliği

Ferritin 19 µg/L 30-400 Düşük demir deposu

Iron 15 µg/dL 59-158 Belirgin düşük

Transferrin sat. ~4,4 % - Hesaplanan, çok düşük

B12 638 pg/mL 211-946 Yeterli görünüyor

En önemli longitudinal bulgu, 23 Temmuz'da HGB'nin 11,3 g/dL iken 27 Temmuz'da 7,7 g/dL'ye düşmesi ve 28 Temmuz'da 8,1 g/dL olmasıdır. Aynı dönemde INR 1,79'dan 1,17'ye inerken yoğun sternal yara tedavisi ve müdahaleleri yapılmıştır. Veri seti düşüşün kesin nedenini (kan kaybı, hemodilüsyon, operasyon, inflamasyon, transfüzyon vb.) tek başına kanıtlamıyor; ancak mevcut demir eksikliği, bu dönemle birlikte ayrıca araştırılması gereken bir demir kaybı ihtimalini gündeme getiriyor.

Erkek hastada demir eksikliği anemisi saptandığında, yalnızca demir başlanmasıyla yetinmeden kan kaybı/malabsorbsiyon nedeni araştırılır. BSG yaklaşımı, uygun hastada üst ve alt gastrointestinal sistemin değerlendirilmesini temel araştırma yollarından biri olarak kabul eder; klinik bağlama göre gastroenteroloji değerlendirmesi gerekir [4].

Öncelik sırası | | Bu laboratuvar örüntüsü “hafif bir laboratuvar sapması” değildir. HGB 9,7 g/dL düzeyi, çok düşük demir saturasyonu ve mikrositoz birlikte | düşünüldüğünde hematoloji/gastroenteroloji ve kardioloji/KVC ile | koordineli değerlendirme uygundur. Özellikle melena, dışkıda kan, | hematüri, artan halsizlik/nefes darlığı veya tekrarlayan düşen HGB | varsa gecikmeden değerlendirilmelidir. |

8. Böbrek fonksiyonu, metabolik profil ve diğer laboratuvarlar

Parametre 08.09.2026 Önceki Yorum

Kreatinin 1,02 mg/dL 1,12 (02.09) İyileşme; normal aralık.

BUN 11 mg/dL 13 Normal.

WBC 7,97 x10⁹/L 9,96 (02.09) Normal aralık; inflamasyon yükü düşüyor.

PLT 365 x10⁹/L 357 Normal ve stabil.

CRP 11,3 mg/L 23,8 (02.09) Düşmüş ancak referans üstü.

LDL 141 mg/dL 119,6 (19.02) Artmış.

HDL 34 mg/dL 35,4 (19.02) Düşük.

Total kolesterol 210 mg/dL 179 Yüksek.

Trigliserid 164 mg/dL 123 Artmış.

HbA1c 5,3 % - Diyabet lehine değil.

TSH 0,279 mIU/L 0,86 (19.02) Alt sınıra yakın; FT4/FT3 normal.

Troponin T 6,01 ng/L 7,61 (19.02) Referans içinde.

Böbrek fonksiyonu açısından 8 Eylül'de kreatinin 1,02 mg/dL ve BUN 11 mg/dL olması olumlu bir seyir gösteriyor. Bu, hem antihipertansif tedavinin hem de kontrastlı görüntüleme planlarının önündeki risk değerlendirmesinde elverişli bir veri noktasıdır; ancak görüntüleme öncesinde güncel kreatinin/eGFR tekrar kontrol edilebilir.

Lipid profili Şubat'taki 119,6 mg/dL LDL'den 141 mg/dL'ye, total kolesterol 179'dan 210 mg/dL'ye yükselmiş ve HDL 34 mg/dL'ye düşmüş. 2022 ACC/AHA aort kılavuzu aterosklerotik aort hastalığında statin kullanımını destekler; ancak izole, aterosklerotik olmayan diseksiyon için statin hedefinin ne olması gerektiğine dair kanıt daha sınırlıdır [6]. Bu nedenle lipid tedavisi, koroner/PAD/aterosklerotik plak, yaş ve toplam kardiyovasküler riskle birlikte hekim tarafından kararlaştırılmalıdır.

8 Eylül TSH 0,279 mIU/L alt sınıra yakındır, ancak serbest T4 1,45 ng/dL ve serbest T3 2,58 ng/L referans içinde. Bu veriler tek başına belirgin tirotoksikoz göstermiyor; klinik semptom varsa izlem/tekrar test gerekebilir.

9. Kilo, sıvı dengesi ve fonksiyonel gidişat

Toplam 175 kilo kaydı 74,8-85,3 kg aralığında. 23 Temmuz-10 Eylül döneminde 41 ölçümün ortalaması 78,74 kg; 10 Eylül son ölçüm 78,4 kg. Son 7 günde 78,4-79,4 kg

arasında dar bir bantta seyir var. Bu, hızlı sıvı yüklenmesi açısından belirgin bir sinyal göstermiyor; ancak ödem değerlendirmesi yalnızca tartıya dayanmaz.

Dönem Ölçüm Ortalama Aralık Son değer sayısı****

Tüm kayıtlar 175 - 74,8-85,3 kg 78,4 kg

23.07-10.09 41 78,74 kg 77,9-80,0 kg 78,4 kg

04.09-10.09 8 78,78 kg 78,4-79,4 kg 78,4 kg

174 cm ve 78,4 kg üzerinden BMI yaklaşık 25,9 kg/m²'dir. Bu, raporun ana klinik sorunlarından biri değildir; şu aşamada daha önemli olan anemi, enfeksiyon/yara ve aort/antikoagülasyon takipleridir.

10. İlaç tedavisi ve önemli etkileşimler

İlaç / sınıf Dosyadaki güncel Analitik not kayıt

Warfarin Haftalık toplam 20 mg Mekanik kapak için temel tedavi; INR yakın izlenmeli.

Dilatrend (carvedilol) 6,25 mg x2/gün Beta-blokaj; aort duvar stresinin azaltılması açısından uygun sınıf.

Coversyl (perindopril) 5 mg/gün Kan basıncı kontrolü için.

EcopirinPro (ASA) 81 mg/gün Warfarin ile birlikte; endikasyon/kanama riski yeniden doğrulanmalı.

Panto 40 mg/gün Gastrointestinal koruma; Ferro Sanol'den 1 saat sonra alınmalıdır.

Ferro Sanol Duodenal 100 mg (Fe²⁺)/gün; Ağır mikrositik demir eksikliği 11.09 başlangıç anemisi tedavisi; sabah aç karnına (Panto'dan 1 saat önce).

Klamoks (tamamlandı) 1000 mg x2/gün; 04.09- 7 günlük kür 10 Eylül 20:59'da 10.09 (kesildi) tamamlandı; INR 2,12 ile stabil seyretti [8].

Cipro (geçmiş) 750 mg x2/gün, Warfarin etkisini 28.07-04.08 artırabilir; dönemsel INR takibi gerekir [9].

Oksapar/enoksaparin 0,6 mL x2/gün, Bridging/antikoagülasyon (geçmiş) 27.07-03.08 kaydı; endikasyon ve hedef doz klinik dosyadan teyit edilmeli.

Klamoks kürü tamamlanması ve warfarin izlemi | | 4 Eylül'de başlanan 7 günlük ampirik Klamoks (amoksisilin/klavulanat) kürü 10 Eylül 20:59'da tamamlanarak kesilmiştir. Kür bitiminde 10 | Eylül saat 16:57'de yapılan kontrol testinde INR 2,12 (PT 19,8 s, | aPTT 44,8 s) ölçülmüş; korkulan supratherapötik dalgalanma yaşanmamış, INR hedef aralıkta kalmıştır [8]. 10 Eylül'de reçetelenen Ferro | Sanol Duodenal 100 mg tedavisine ise 11 Eylül sabahı başlanmıştır. |

2025 ESC/EACTS kılavuzu mekanik kapaklı hastalarda VKA tedavisinin INR hedefini kapak tipi ve ek tromboembolik risk faktörlerine göre belirler. Dosyada atriyal fibrilasyon, LVEF<35%, yakın dönem tromboembolizm veya bilinen hiperkoagülabilité gibi risk faktörlerine dair yeterli kanıt bulunmadığından, 2,0-3,0 aralığı en olası referanstır; kesin hedef kardiyoloji tarafından doğrulanmalıdır [2].

11. Genel gidişat: stabilizasyon var, fakat düşük riskli dönem henüz değil

Alan Durum Gerekçe

Hemodinami İYİLEŞEN / STABİL Son hafta 111/75; ciddi hipertansif ataklar belirgin azalmış.

Aort anatomisi İZLEM GEREKİR Operasyon yatağı stabil, ancak distal rezidüel diseksiyon devam ediyor.

Mekanik kapak STABİL, YAKIN İZLEM Son INR 2,12 uygun; tarihsel INR dalgalanması belirgin.

Enfeksiyon/yara KISMEN İYİLEŞEN CRP 23,8 → 11,3, WBC 9,96 → 7,97; ancak normalleşmiş değil.

Anemi/demir ÖNCELİKLİ SORUN HGB 9,7 + ferritin 19 + Fe 15 + MCV 76,4. 10 Eylül'de Ferro Sanol 100 mg başlandı.

Böbrek İYİ Kreatinin 1,02; son değerinde düzelme.

Kilo/sıvı STABİL Son 7 gün dar aralıkta, 78,4 kg.

Lipid İYİLEŞTİRİLMELİ LDL 141, HDL 34, total kolesterol 210.

Net prognostik değerlendirme: Şubat 2026'daki akut olaydan sonraki en kırılgan erken dönem büyük ölçüde geride kalmış ve özellikle kan basıncı ile renal fonksiyonlarda belirgin stabilizasyon elde edilmiş görünüyor. Ancak "tamamen düzeldi" denecek bir tablo yoktur. Uzun dönem riskin ana belirleyicileri; rezidüel diseksiyonun büyüme davranışı, mekanik kapak antikoagülasyonunun kalitesi, sternal enfeksiyonun tam eradikasyonu ve demir eksikliği anemisinin nedeninin bulunup düzeltilmesidir.

12. Önceliklendirilmiş izlem planı

- 1) KVC/aort cerrahisi: 5 Mayıs sonrası planlanan 6 aylık toraks-abdomen-pelvis CTA veya MR görüntülemesinin yapıp yapılmadığını teyit etmek; rezidüel diseksiyon ve aort çaplarını seri ölçümle karşılaştırmak [1].
- 2) Antikoagülasyon: Son INR 2,12 (10 Eylül) uygun olsa da antibiyotik sonrası geç etkiler ve tarihsel dalgalanmalar nedeniyle yakın INR kontrolü planlamak; kanama ve tromboz belirtilerini ayrı ayrı izlemek [2,8].
- 3) Anemi: HGB, retikülosit, ferritin, demir, transferrin satürasyonu izlemi; erkek hastada demir eksikliğinin kaynağı için gastroenteroloji/hematoloji değerlendirmesi; gerekli görülürse üst ve alt GI inceleme [4].
- 4) Sternal yara/enfeksiyon: yaranın fizik muayene ve mikrobiyolojik planla izlenmesi; ateş, pürülan akıntı veya artan CRP/WBC durumunda enfeksiyon hastalıkları + KVC iş birliği; endokardit şüphesinde TTE/TEE ve uygun kan kültürleri [3].
- 5) Kardiyoloji: mekanik kapağın fonksiyonunu ve LV fonksiyonunu gösteren güncel ekokardiyografinin dosyada olup olmadığını kontrol etmek; özellikle yeni dispne, ödem, senkop veya kapak sesi değişikliği varsa gecikmemek [1,2].

- 6) Risk faktörleri: LDL 141 mg/dL için toplam kardiyovasküler risk, aterosklerotik plak/CAD/PAD ve mevcut ilaçlarla birlikte lipid düşürücü tedavi gereksinimini değerlendirmek [6].
- 7) Veri yönetimi: İlaç listesini reçete/epikriz ile tekilleştirmek; otomatik rapor ile ham ilaç değişiklikleri arasındaki çelişkileri düzeltmek.

13. Acil değerlendirme gerektiren uyarı işaretleri

Bu bölüm tanı koymak için değil, yüksek riskli geçmiş nedeniyle hangi belirtilerin bekletilmemesi gerektiğini özetlemek içindir.

- Yeni başlayan veya alışılmadık şiddette göğüs/sırt/karın ağrısı, özellikle ani ve yırtıcı karakterde ağrı.
- Yeni nörolojik bulgu: konuşma bozukluğu, tek taraflı güçsüzlük/uyuşma, yüz asimetrisi, bilinç değişikliği.
- Belirgin nefes darlığı, bayılma/senkop, morarma veya yeni gelişen hızlı/çok düzensiz nabız.
- 38°C ve üzeri ateş, titreme, kötüleşen yara kızarıklığı, irinli akıntı veya sternal ayrılmanın tekrar belirlenmesi.
- Siyah-katran dışkı, görünür kanlı dışkı/idrar, durmayan burun/diş eti kanaması, büyük morarmalar veya kanlı kusma.
- Belirgin halsizlik/nefes darlığı ile birlikte anemi hızla kötüleşiyorsa.
- Yeni belirgin bacak şişliği, akut tek taraflı ekstremitte ağrısı/soğukluğu veya emboli düşündüren bulgular.

Özellikle aort ve mekanik kapak öyküsü nedeniyle | | Ani göğüs/sırt ağrısı veya yeni nörolojik belirti ortaya çıkarsa, | geçmişte benzer belirti “önemsiz” çıkmış olsa bile acil değerlendirme gerekir. Warfarin kullanımı nedeniyle kanama şüphesinde de beklemek | uygun değildir. |

14. Ham veri eki: kritik longitudinal seri

14.1 INR serisi

Tarih/saat INR 2,0-3,0 aralığı

19.02.2026 17:22 1.10 Düşük
19.02.2026 18:45 1.14 Düşük
19.02.2026 23:23 1.10 Düşük
21.02.2026 00:11 1.29 Düşük
22.02.2026 00:29 1.24 Düşük
23.02.2026 04:22 1.23 Düşük
24.02.2026 00:09 1.28 Düşük
25.02.2026 00:35 1.49 Düşük
26.02.2026 00:03 1.68 Düşük
27.02.2026 00:58 1.92 Düşük
28.02.2026 00:26 2.16 Hedef içi
01.03.2026 00:04 2.55 Hedef içi
02.03.2026 01:00 3.36 Yüksek
12.03.2026 09:00 5.74 Yüksek
16.03.2026 20:24 8.46 Yüksek
18.03.2026 20:14 6.04 Yüksek
20.03.2026 22:48 5.87 Yüksek
23.03.2026 08:41 4.52 Yüksek
30.03.2026 14:16 4.64 Yüksek
08.04.2026 16:01 2.92 Hedef içi
20.04.2026 22:51 2.03 Hedef içi
05.05.2026 11:36 1.77 Düşük
12.05.2026 15:27 1.65 Düşük
13.05.2026 11:42 1.94 Düşük

22.05.2026 13:30 2.05 Hedef içi

15.06.2026 12:36 2.18 Hedef içi

15.07.2026 15:21 2.46 Hedef içi

23.07.2026 11:15 1.79 Düşük

25.07.2026 00:07 1.70 Düşük

26.07.2026 01:05 1.38 Düşük

27.07.2026 00:21 1.17 Düşük

31.07.2026 13:34 1.18 Düşük

03.08.2026 14:16 1.21 Düşük

07.08.2026 20:11 1.55 Düşük

11.08.2026 08:59 1.70 Düşük

18.08.2026 10:31 2.59 Hedef içi

25.08.2026 15:29 2.76 Hedef içi

02.09.2026 20:27 2.72 Hedef içi

10.09.2026 16:57 2.12 Hedef içi

14.2 Son laboratuvar paneli

Kod Tarih Sonuç Birim Lab referansı

HGB 08.09.2026 9.7 g/dL 13.5000 - 14:15 17.5000

HCT 08.09.2026 29.7 % 40.0000 - 14:15 52.0000

RBC 08.09.2026 3.89 10¹²/L 4.2000 - 14:15 6.2000

MCV 08.09.2026 76.4 fL 80.0000 - 14:15 100.0000

MCH 08.09.2026 24.9 pg 27.0000 - 14:15 34.0000

RDW-CV 08.09.2026 17.8 % 10.0000 - 14:15 16.5000

RDW-SD 08.09.2026 50.8 fL 37.0000 - 14:15 49.0000
FERRITIN 08.09.2026 19 µg/L 30.0000 - 14:15 400.0000
IRON 08.09.2026 15 µg/dL 59.0000 - 14:15 158.0000
WBC 08.09.2026 7.97 10⁹/L 4.5000 - 14:15 11.0000
CRP 08.09.2026 11.3 mg/L 0.0000 - 14:15 5.0000
PLT 08.09.2026 365 10⁹/L 150.0000 - 14:15 403.0000
CREA 08.09.2026 1.02 mg/dL 0.6000 - 14:15 1.3000
BUN 08.09.2026 11 mg/dL 7.0000 - 14:15 28.0000
LDL 08.09.2026 141 mg/dL 60.0000 - 14:15 130.0000
HDL 08.09.2026 34 mg/dL 35.0000 - 14:15 75.0000
CHOL 08.09.2026 210 mg/dL 140.0000 - 14:15 200.0000
TRIG 08.09.2026 164 mg/dL 55.0000 - 14:15 200.0000
B12 08.09.2026 638 pg/mL 211.0000 - 14:15 946.0000
TSH 08.09.2026 0.279 mIU/L 0.2700 - 14:15 4.2000
FT4 08.09.2026 1.45 ng/dL 0.9300 - 14:15 1.7000
FT3 08.09.2026 2.58 ng/L 2.0000 - 14:15 4.4000
TROP-T 08.09.2026 6.01 ng/L 0.0000 - 14:15 14.0000

15. Kaynaklar ve kanıt tabanı

- [1]** Isselbacher EM et al. 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease. *Circulation*. 2022;146:e334-e482. | <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001106>
- [2]** 2025 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal / European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*. 2025. | <https://academic.oup.com/ejcts/article/doi/10.1093/ejcts/ezaf276/8242828>
- [3]** 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis; key diagnostic principles and prosthetic-valve endocarditis considerations. *European Heart Journal*. 2023. | <https://academic.oup.com/eurheartj/article/45/19/1697/7649218>

[4] British Society of Gastroenterology approach to adult iron deficiency anaemia: ferritin/iron studies and GI evaluation principles. Gut. 2021. | <https://gut.bmj.com/content/70/7>

[5] 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension - treatment target summary. European Heart Journal. 2024. | <https://academic.oup.com/eurheartj/article/45/38/3897/7815005>

[6] 2022 ACC/AHA Aortic Disease Guideline - statin therapy considerations in aortic disease/atherosclerosis. | <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001106>

[7] 2025 ESC/EACTS mechanical valve INR table (bileaflet aortic MHV target 2.5, range 2-3 without additional prothrombotic factors). | <https://academic.oup.com/view-large/553229227>

[8] DailyMed. Amoxicillin and clavulanate potassium - oral anticoagulants interaction; abnormal prolongation of PT/INR reported, monitoring advised. Updated July 2026. | <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=1127a41b-14a1-4fe8-ae37-67ea5d760301>

[9] DailyMed. Ciprofloxacin - oral anticoagulants interaction; increased anticoagulant effect and need for frequent PT/INR monitoring. | <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=888dc7f9-ad9c-4c00-8d50-8ddfd9bd27c0>

[10] Yüklenen hasta veri dosyası: Alaattin Sönmez Boylamsal Klinik Veri Tabanı (19 Şubat – 10 Eylül 2026 Tüm Tıbbi Kayıtlar).

16. Sonuç

10 Eylül 2026 itibarıyla hasta, Şubat 2026'daki akut Tip A aort diseksiyonu ve Bentall ameliyatından sonraki ilk ağır komplikasyon dönemini aşmış, özellikle kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarında belirgin stabilizasyon sağlamış durumdadır. Bununla birlikte klinik risk sıfırlanmamıştır. Rezidüel diseksiyonun seri görüntüleme ile takip edilmesi, mekanik kapağın warfarin yönetiminin daha istikrarlı hale getirilmesi, sternal enfeksiyonun tamamen kontrol edildiğinin doğrulanması ve belirgin demir eksikliği anemisinin nedeninin ortaya konması önümüzdeki dönemin ana başlıklarıdır.

Yakın dönemde tamamlanan 7 günlük Klamoks kürü (10 Eylül 20:59) sonrası yapılan kontrolde INR 2,12 ile hedefte kalmış ve korkulan supratherapötik sıçrama görülmemiştir. 10 Eylül'de reçetelenip 11 Eylül sabahı başlanan Ferro Sanol

Duodenal 100 mg ile demir eksikliği anemisine yönelik replasman başlatılmıştır; gastrointestinal tolerans ve antikoagülasyon dengesi izlenmelidir [2,8].

Bu raporun klinik olarak kullanılabilecek en önemli çıktısı, “şu anda kötüleşiyor mu?” sorusuna yanıtın genel olarak hayır, ancak “tamamen güvenli/stabil mi?” sorusuna yanıtın henüz hayır olduğudur. En güçlü olumlu sinyaller hemodinamik stabilizasyon ve renal fonksiyondaki düzelmedir; en önemli açık konular ise rezidüel aort hastalığı, antikoagülasyon kalitesi, sternal enfeksiyonun kesin eradikasyonu ve demir eksikliği anemisinin nedeni olmaya devam etmektedir.